三维分析框架下省域康养旅游政策量化研究

安利娟,熊国保,杨天瑶

(东华理工大学 经济与管理学院,江西 南昌 330029)

[摘要]大力发展康养旅游成为旅游业转型升级的重要路径之一,了解当下康养旅游政策特征及未来发展导向将助力康养旅游发展提质增效。文章首先综述了国外康养旅游政策相关成果,然后以 2007—2022 年 24 个省级政府出台的 86 份康养旅游政策为研究对象,使用文本分析法与 PMC 指数模型,构建了“政策主题—政策工具—政策效力”三维分析框架以了解政策相关特征及其存在的问题。通过对词语云、词频表以及自动编码结果的分析发现,康养旅游政策主题集中于产业发展、产品开发、企业参与、体制机制创新、基础设施建设以及康养人才培养与技术开发等方面;在自动编码的基础上对政策文本进行深入手动编码以探究政策工具使用情况,结果表明当下政策工具使用失衡,其中环境型政策工具占比 68.93%,远远高于供给型(16.69%)与需求型(14.39%)政策工具,沿海地区与其他地区在政策工具的使用上因其地理位置与经济发展水平出现不同方面的差异;基于 PMC 指数模型测算结果表明,康养旅游政策样本整体效力表现良好,不足之处在于缺少法律保障、技术支撑以及相关优惠政策支持。据此文章提出了康养旅游政策制定的相关建议。

[关键词]康养旅游;PMC 指数模型;文本分析法;三维分析框架;健康

中图分类号:F592.0 **文章标志码**:A **文章编号**:1672-0563(2024)01-0018-11

DOI:10.13773/j.cnki.51-1637/z.2024.01.003

2012 年 12 月《中国的医疗卫生事业》白皮书将中国居民的健康水平拖入了大众视野,党中央也对全国的健康事业给予较大的关注,随后在各大会议上,“健康”成为党中央热议的话题并相继出台各大政策和发展战略,直至 2016 年 8 月 26 日,《“健康中国 2030”规划纲要》应运而生,对国家未来 15 年的健康建设做出了总体部署[1]。如果说康养是实施“健康中国”战略的内在要求,那康养旅游就是实施康养的重要路径之一。自 2016 年“健康中国”战略和《国家康养旅游示范基地》标准出台以来,国家、部门、地方间的康养旅游政策如雨后春笋般涌现。随着康养旅游发展得如火如荼,国内外资本大量流入康养旅游产业,中央和地方政府纷纷出台康养旅游政策对其发展进行干预,国家层

收稿日期:2023-04-17
基金项目:江西省社会科学“十四五”(2022 年)基金项目“江西康养旅游高质量发展路径与对策研究”(22WT14)。
作者简介:安利娟,硕士研究生,E-mail:1298326931@qq.com;熊国保,教授,博士,硕士生导师;杨天瑶,硕士研究生。

面的康养政策已涉及方方面面,但部门间、地方间的政策并不能有效贯通,还存在诸多政策堵点[2]。当前,中央各部门发布的康养旅游相关政策主要问题在于政策宏观性太强、缺少操作细则、国家在资金投入方面所占比重轻、缺少专业的旅游人才与培养等[3],尤其缺少对地方政府出台的政策研究,因此对省域康养旅游政策的研究能使公众更好地了解康养旅游的发展状况,了解政策中还存在哪些盲点与不足。

一、国外康养旅游政策述评

康养旅游政策在国家之间、国家内部都会因其经济状况、文化差异等因素而有所不同,国外康养旅游的发展起步较早,到今天已经形成了相对成熟的体系,其政策主要集中在医疗康养、森林康养以及温泉康养等方面。

(一)医疗康养

医疗旅游方面,泰国、印度和新加坡政府为本国的医疗旅游产业提供了官方支持,通过参加大型国际贸易会议,积极宣传本国医疗旅游服务,在泰国、新加坡和马来西亚可以获得医疗旅游签证,以增加医疗旅游客流,法律文献也开始涵盖在海外进行手术时的病人责任问题[4]。蒙古政府为了发展医疗旅游,从卫生系统的资金投入、卫生工作者的培训以及护理文化上出台了政策[5]。2016 年,韩国政府为了加快医疗旅游产业的发展,制定了《支持医疗体系海外扩张和吸引国际患者法》,制定了涵盖国内和外国患者的医疗事故保险政策,而且在韩国还允许使用外语播放医疗广告。印度通过简化移民入境程序来吸引更多的医疗游客,它还通过降低进口关税和提高一些医疗设备的会计折旧率对医疗旅游提供者实行税收减免,同时还为提供医疗旅游服务的医院提供价格补贴[6]。

(二)森林康养

在森林旅游方面做得比较出色的日本以及韩国也出台了相关政策。韩国依据《森林休养法》和《森林福祉法》的规定,对森林福祉专业服务人才实行分级分类管理,由山林厅或山林福祉振兴院组织实施相应的培训考试,由山林厅统一制作颁发资格证书;进行多元化森林福祉服务设施建设;提高经营效率和管理效能;建立健全配套法规等[7]。日本政府于 2016 年 3 月制定了“未来日本观光梦想”计划,确定观光立国政策,致力休养林建设;推行森林疗法向导和森林理疗师资格考试制度;增强资金支持力度,促进森林中木制小屋等设施的建造及向导培训等[8]。欧美部分国家主要通过刺激需求、完善供给、优化环境及强化参与等措施促进旅游业的发展,市场营销、产品多样化、服务质量、协调与合作、投融资、文化自然遗产、设施改善及技术知识是其旅游政策的重要关注点,他们致力于促进增长与就业、改善品牌形象及提升竞争力[9]。

(三)温泉康养

关于温泉旅游,在斯洛伐克,温泉疗养被纳入公共医疗保险范畴,护理费用全部或部分报销,尽管政策力度有所变化,但是温泉疗养领域一直享受着政策优待,且在该领域实行了实施税收优惠制度[10]。日本作为亚太地区温泉旅游收入最高的国家之一,温泉旅游入境游客的免税制度目前正在通过税收改革得到加强[11]。西班牙有专门负责管理老年人的补充社会服务的社会保障系统机构,而这些服务中就包括社会旅游和老年人温泉疗养,在西班牙安达卢西亚,部分专家认为目前的法律

环境给温泉的发展带来了困难,因为各部委(即旅游和卫生)之间共享权限,而且缺乏具体的自治社区立法[12]。在温泉发展问题上,捷克共和国、匈牙利、波兰和斯洛伐克等地区重点关注国际项目,而欧盟的资金主要帮助恢复和发展基础设施[13]。

综上所述,一些致力于医疗旅游的国家都有一个通用的手段,即通过开放医疗旅游签证来获取更多的医疗旅游流入,医疗旅游对这些国家的医疗技术水平有较高的要求,不管是正在发展还是已经形成较为成熟的医疗旅游体系,这些国家在卫生系统上依旧存在较大的资金投入和政府支持。森林旅游则更多地依赖于该国原有的森林和绿化资源,对环境的要求更高,对专业的森林理疗从业人员的培养投入也更高。无论是医疗旅游、温泉旅游还是森林旅游,对配套的法律法规体系和高效的管理制度的建设都有较高的门槛。

二、研究设计

(一)研究方法

本文使用 NVivo 11plus 软件进行文本分析。NVivo 是由 QSR 公司开发的一款文本质性分析软件,能够对文章、访谈、调查结果、音频、视频、图片、网页或社交媒体等内容进行处理,将高频词、主题词等信息以词语云、矩形图、聚类分析图等形式呈现出来,并将与研究主题相关的信息点编码汇总[14]。NVivo 文本分析除了对文章、访谈等内容进行处理,近年来也被广泛应用与政策分析领域,能够通过自动编码和手动编码等方式对政策内容进行深入挖掘。

PMC 指数模型是由 Estrada 等(2011)[15]人提出的,PMC 指数使政策制定者和研究人员能够确定任何政策模型中的一致性水平以及优势和劣势,促进了政策建模的多学科方法。PMC 指数法包括四个实施步骤:1)使用多投入产出表;2)变量分类和参数识别;3)PMC 指数的测量;4)PMC 曲面图的建造。

(二)研究框架

本文参考高昕(2022)[16]和陈子凤(2023)[17]的研究成果,结合 NVivo 文本分析,构建“主题—工具—效力”三维分析框架,如图 1 所示。X 轴(政策主题)由核心内容和关注点组成,是对康养旅游政策文本进行挖掘得到的重要信息;Y 轴(政策工具)由环境型、需求型、供给型组成,是对政策内容进行分析时采用的政策工具;Z 轴(政策效力)由不良、可接受、良好、优秀四个等级组成,通过 PMC 指数模型计算得出。

(三)材料来源

本文以省级康养旅游政策为研究对象,通过访问各省人民政府网和文旅厅等相关官方网站的政策法规,以“康养(旅游)”“健康(旅游)”“医疗(康养)”“森林(康养)”“温泉(康养)”等为关键词进行搜索,查找与康养旅游相关的政策文件,并对搜集到的政策文件进行人工筛选。在进行政策文本筛选时,只选取法律法规、规定、决定、意见、通知、办法、条例等权威性政策文件,最终得到 2007—2022 年期间 24 个省份 86 份政策文件,在 2015 年之后,即国家正式出台《国家康养旅游示范基地》标准之后,康养旅游政策发文量持续增多,且政策文本中通知和意见类文件占绝大多数,其中发文数量较多的是 2016 年、2017 年、2018 年、2022 年。

三、政策分析

(一)政策主题分析

将康养旅游政策文本导入 NVivo 软件中进行词频查询,经人工剔除无意义词语后,得到康养旅游政策词语云(图 2)及康养旅游政策词频统计表(表 1)。其中,旅游、产业、健康、企业、产品、景区、中医药以及生态等与康养旅游领域高度相关的词汇占据了较大比重,说明各地方政府尤其重视在康养旅游发展过程中与产业发展、产品开发、企业参与等紧密相关的政策制定。其次,从创新、体系、基地、乡村、技术、平台等次级高频词可以看出,相关领域体制机制的创新、康养旅游基地建设、乡村建设与发展、技术提升以及各种平台的建立对于康养旅游的发展有着举足轻重的影响。最后,从人才、森林、中医、温泉、体育等高频词可知,康养旅游的发展除了依托于森林资源、中医药资源、温泉资源等有益于人们进行康养活动的自然资源外,还依赖于专业性与高素质的康养人才与相关康体健身的基础设施。

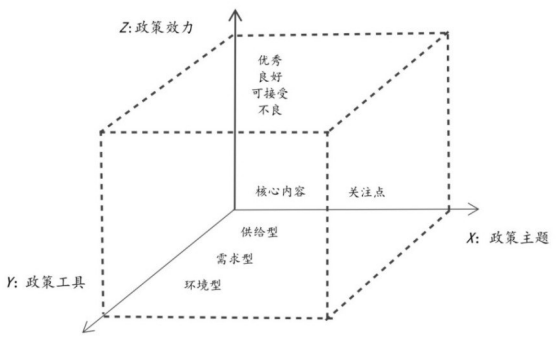


图 1　康养旅游政策三维评价框架



图 2　康养旅游政策词语云

表 1　康养旅游政策词频统计表

序号	单词	计数	加权百分比(%)	序号	单词	计数	加权百分比(%)
1	旅游	16888	3. 86	18	市场	1436	0. 33
2	发展	6340	1. 45	19	机构	1413	0. 32
3	服务	4879	1. 12	20	创新	1395	0. 32
4	文化	4498	1. 03	21	体系	1320	0. 30
5	建设	4446	1. 02	22	国际	1319	0. 30
6	产业	3699	0. 85	23	休闲	1307	0. 30
7	健康	3390	0. 78	24	管理	1284	0. 29
8	企业	2167	0. 50	25	养老	1211	0. 28
9	产品	1839	0. 42	26	开发	1207	0. 28
10	资源	1800	0. 41	27	品牌	1189	0. 27
11	景区	1678	0. 38	28	完善	1172	0. 27
12	医疗	1663	0. 38	29	基地	1165	0. 27
13	项目	1643	0. 38	30	国家	1164	0. 27
14	特色	1642	0. 38	31	基地	1165	0. 27
15	重点	1614	0. 37	32	国家	1164	0. 27
16	中医药	1551	0. 35	33	规划	1158	0. 26
17	生态	1517	0. 35	34	度假	1086	0. 25

续表 1

序号	单词	计数	加权百分比(%)	序号	单词	计数	加权百分比(%)
35	乡村	1049	0.24	48	医药	822	0.19
36	社会	1030	0.24	49	工作	817	0.19
37	技术	998	0.23	50	改革	815	0.19
38	融合	945	0.22	51	促进	803	0.18
39	政府	934	0.21	52	人才	782	0.18
40	设施	919	0.21	53	森林	715	0.16
41	养生	905	0.21	54	中医	708	0.16
42	政策	886	0.20	55	温泉	707	0.16
43	平台	875	0.20	56	体育	701	0.16
44	消费	865	0.20	57	工程	690	0.16
45	合作	855	0.20	58	示范	690	0.16
46	综合	851	0.19	59	信息	683	0.16
47	机制	845	0.19	60	标准	677	0.15

经过 NVivo 系统自动编码分析,生成了以“旅游、产业、发展、服务、建设、文化、省”七大核心主题构成的板块,每一板块包含了所有与该主题紧密相关的内容,本文将七大板块之间以一定的逻辑联系在一起。“省”表示在政策制定与实施过程中参与的政府部门,包括省药品监管局、省自然资源厅、省海洋局、省科技厅、省林业和草原局、省环保厅、省扶贫办等一系列与康养旅游发展紧密相关的政府部门,这些部门在各自所属的管辖领域内对康养旅游的发展群策群力;“产业”是政府部门在进行规划的过程中的着手点,包括旅游、信息、健康,医疗、保健品、海洋生物、影视以及花卉林木等产业,对康养旅游的发展起到重要作用;“发展”“服务”“建设”三大针对各大产业的具体政策措施板块,在康养旅游目的地多元化的文化影响下,对康养旅游(具体包括森林旅游、中医药旅游、温泉旅游等专项旅游形式)的快速、高质量发展形成政策合力。

(二)政策工具分析

政策工具是政府在实现政策目标过程中采取的一系列手段的总和。本文参考 Rothwell 和 Zegveld(1984)[18]的研究成果,将政策工具分为供给型、需求型、环境型政策工具,在自动编码的基础上对政策文本逐句进行手动编码,共得到 2391 个参考点,具体统计数据如表 2 所示,其中环境型政策工具占比最大,为 68.93%,供给型政策工具次之,16.69%,需求型政策工具最少,占比 14.39%。在三种政策工具中,环境型政策工具数量占据了绝对优势,其子分类中,产业发展策略占比最多(47.64%),依次是目标与规划(14.18%)、法律与制度建设(4.85%)、金融与财税支持(2.26%),此项数据说明地方政府在康养旅游的发展上采取了大量的策略性措施,对其发展进行了更加具体、实际的规划,有利于下级部门更好地执行相关政策,其次,由于康养旅游的发展在某种程度上是实践先于理论,因此相关方面的制度体系与标准建设在后来的发展过程中也得到了相应的重视,金融与财税支持也紧跟其上。供给型政策工具中,基础设施建设比重最大(8.82%),在所有类型政策工具中比重也较高,说明康养旅游的发展在较大程度上需要加大对基础设施的建设与完善,也从侧面说明目前我国康养旅游发展还有很大的提升空间,在人才培养与引进(3.47%)、科技与信息支持(2.93%)以及资金支持(1.46%)方面,地方政府虽然给予了一定支持,但从其对康养旅游发展的重要性来看,相关的政策措施还应继续向其倾斜,加大支持力度。需求型政策工具中,地方政府对康养

旅游市场调动(12.42%)给予了较大关注,一个产业的发展仅靠政府的支持无疑是杯水车薪,只有带动市场参与主体的积极性,才产生更大的发展动力,此外,加强国际交流与合作(1.80%),提升国内康养旅游品牌知名度,扩大海外市场对于康养旅游的发展也十分重要,但是政府采购(0.17%)对于大部分产业来说所占比重很低,这与各省份经济发展状况关系较大,因此地方政府可根据自身经济实力适当加大政府采购力度,在康养旅游发展的关键时刻给予一定支持。

表 2　政策工具分类、占比及其释义

工具类型	工具名称	占比	工具释义
供给型政策工具	资金支持	1.46%	政府对康养旅游的发展提供直接的财政支持,如政府直接投资、发放补贴等
	科技与信息支持	2.93%	支持相关科技机构建设与发展,提升康养旅游的信息化水平,如各种平台、数据库的建设
	基础设施建设	8.82%	相关基地、设施建设与完善
	人才培养与引进	3.47%	培养、引进专业性康养旅游产业人才
环境型政策工具	目标规划	14.18%	描述远景、目标并对其实现做出大致方向的规划
	法规与制度建设	4.85%	建立并完善康养旅游相关的法律法规、制度体系与标准
	金融与财税支持	2.26%	通过放宽金融约束、提供税收优惠等政策为企业等市场参与主体提供进入、发展的机会
	产业发展策略	42.64%	一切有利于促进康养旅游相关产业发展的实际性的、具体性的方法、措施与手段
需求型政策工具	市场调动	12.42%	通过各种措施鼓励、调动个人、企业及其他市场参与主体的积极性,使其参与到康养旅游市场的建设与发展,增强市场活力
	国际交流与合作	1.80%	支持企业、个人以及相关组织和团体进行康养旅游的国际性宣传、交流与合作,扩大康养旅游市场
	政府购买	0.17%	政府直接使用财政资金对康养旅游相关产品与服务进行购买

为了进一步了解地方政府康养旅游政策制定的规律,本文对康养旅游政策工具进行了地区之间的比较,将其分为沿海地区与非沿海地区(包括内陆地区与沿边地区),其对比结果如表 3。在政策工具类型中,沿海地区省份在基础设施建设、科技与信息支持、法规与制度建设、国际交流与合作、市场调动以及政府采购方面发布了相对较多的政策措施,符合人们对沿海城市发达、开放的印象,而非沿海地区的康养旅游政策则在人才培养与引进、资金支持以及金融与财税支持方面占据较大比重。对于沿海地区而言,其发达的经济吸引了更多更好的人才流入,有着更加先进的科学技术,因此利用这些优势更加注重市场的规范化管理,注重打造国际性康养旅游品牌,而非沿海地区由于资源和平台的限制,则更加注重人、财、物的发展,需要借助政府的大力支持带动康养旅游产业的发展。

表 3　康养旅游政策工具对比分析

工具类型	工具名称	地区	
		沿海地区	非沿海地区
供给型	基础设施建设	57.5%	42.50%
	科技与信息支持	54.47%	45.53%
	人才培养与引进	40.39%	59.61%
	资金支持	40.51%	59.49%
环境型	产业发展策略	45.39%	54.62%
	法规与制度建设	51.65%	48.35%
	金融与财税支持	34.46%	65.54%
	目标与规划	49.63%	50.37%

续表 3

工具类型	工具名称	地区	
		沿海地区	非沿海地区
需求型	国际交流与合作	73.77%	26.24%
	市场调动	57.56%	42.44%
	政府采购	56.13%	43.87%

(三)政策效力分析

在进行政策效力评价时,本文从现有的 86 份政策文本筛选出 8 份与康养旅游高度相关的样本进行评价,并将政策样本从 P1 – P8 进行排序,分别是:2011 年 5 月 18 日《江西省人民政府办公厅关于加快发展温泉旅游的若干意见》、2012 年 5 月 26 日《江西省人民政府办公厅关于加快森林旅游发展的意见》、2018 年 4 月 9 日贵州省人民政府办公厅发布的《省人民政府办公厅关于加快温泉旅游产业发展的意见》、2020 年 1 月 1 日广西大健康旅游产业工程指挥部关于印发《广西大健康旅游产业工程实施方案》的通知(桂健康旅游指挥部〔2019〕3 号)、2021 年 3 月 11 日吉林省中医药管理局《关于促进吉林省中医药健康旅游高质量发展的实施意见》、2021 年 11 月 29 日《江西省人民政府办公厅关于推进康养旅游发展的意见》、2022 年 4 月 24 日《山西省人民政府办公厅关于支持康养产业发展的意见》和 2022 年 8 月 3 日黑龙江省文化和旅游厅关于印发《黑龙江省康养旅游高质量发展行动方案(2022 – 2026 年)》的通知。

1. 评价指标体系构建

参考林晓芸等(2022)[19]、王黎萤等(2022)[20]研究,结合康养旅游产业特点与前文分析结果,共选取 9 个一级变量,37 个二级变量,如表 4 所示。

表 4　康养旅游政策 PMC 评价指标

一级变量	二级变量
政策主体 X_1	多部门 X_{11}　单独部门 X_{12}
政策客体 X_2	政府机构 X_{21}　企业 X_{22}　组织或团体 X_{23}　社会公众 X_{24}
政策性质 X_3	预测 X_{31}　监管 X_{32}　建议 X_{33}　描述 X_{34}　引导 X_{35}
政策时效 X_4	短期 X_{41}　中期 X_{42}　长期 X_{43}
政策视角 X_5	宏观 X_{51}　微观 X_{52}
政策领域 X_6	政治 X_{61}　经济 X_{62}　社会 X_{63}　科技 X_{64}　文化 X_{65}　环境 X_{66}
政策评价 X_7	目标明确 X_{71}　依据充分 X_{72}　规划详实 X_{73}
政策方式 X_8	强制性 X_{81}　约束性 X_{82}　服务性 X_{83}
政策措施 X_9	法律保障 X_{91}　技术支持 X_{92}　金融支持 X_{93}　税收优惠 X_{94}　投资补贴 X_{95}　组织实施 X_{96} 市场环境 X_{97}　宣传推广 X_{98}　人才培养 X_{99}

按照传统的做法,本文对二级变量的参数设置采用二进制,即政策文本中出现该变量或该变量相关内容则其值为 1,否则为 0;政策时效部分,政策时期在 1 年以内视为短期,在 1 ~ 5 年内视为中期,5 年以上视为长期;政策主体部分,由于其二级变量之间为互斥关系,则将其取值界定在[0,1]之间,单独部门若是省政府及办公厅则取值为 1,若是省政府及办公厅下级部门则取值 0.4,若是多个下级部门联合发布则取值为 0.7。

2. PMC 指数计算

目前学界对 PMC 指数的计算主要分为四步,首先借助二进制确定二级变量的数值,其次利用二

级变量的值计算出一级变量的值,最后再计算 PMC 指数,其具体计算方式如下:

$$X_{ij} \sim N:[0,1] \tag{1}$$

$$X_i = \{XR:[0 \sim 1]\} \tag{2}$$

二级变量 X_{ij}取值为 0 或 1,一级变量 X_i 取值在 0 ~ 1 之间。

$$X_{ij} = [\sum_{j=1}^{n} \frac{X_{ij}}{T(X_{ij})}] i = 1,2,3,\cdots,n \tag{3}$$

$$PMC = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \frac{X_{ij}}{n(X_{ij})} \tag{4}$$

式中,i 表示第 i 个一级变量,j 表示第 j 个二级变量,m 是一级变量个数,n 是二级变量个数,$T(X_{ij})$为某一级变量下二级变量的个数。

依据 *Estrada* 的评价标准,将政策效力等级分为:[0,4)为不良,[4,6)可接受,[6,8)为良好,[8,9]为优秀。

3. 结果分析

根据上述评价指标体系与计算方法,得到了 8 项康养旅游政策样本的 *PMC* 指数,其结果如表 5 所示。

表 5　*PMC* 政策效力评价表

政策编号	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	*PMC* 指数	等级
*P*1	1	0.75	0.8	0.33	1	0.83	1	1	0.56	7.27	良好
*P*2	1	0.8	1	1	1	0.83	1	1	0.78	8.41	优秀
*P*3	1	1	1	0.6	1	0.83	1	1	0.78	8.21	优秀
*P*4	0.4	0.8	1	0.7	1	1	1	1	1	7.9	良好
*P*5	0.4	0.75	1	0.7	1	0.67	1	0.67	0.56	6.75	良好
*P*6	1	1	1	0.4	1	1	0.67	0.67	0.78	7.52	良好
*P*7	1	1	1	0.4	1	0.83	1	1	0.67	7.9	良好
*P*8	0.4	1	1	1	1	0.83	0.67	0.67	0.78	7.35	良好
平均值	0.78	0.89	0.98	0.64	1.00	0.85	0.92	0.88	0.74	7.66	—

在 8 项政策样本中,*P*2 和 *P*3 表现优秀,其余 6 项政策均达到了良好的标准且有两项接近优秀。在 *P*2 中,有扣分项的指标是 X_2、X_6、X_9,即政策客体、政策领域、政策措施,该项政策在针对社会公众、科技发展、税收优惠方面出现缺口;在 *P*3 中,出现扣分项的指标是 X_4、X_6、X_9,即政策时效、政策领域、政策措施,该项政策在文化融合发展与政府投资补贴方面还需要加大政策支持力度;对于 *PMC* 指数得分最低的 *P*5 政策,其扣分项在于 X_1、X_2、X_4、X_6、X_8、X_9,即政策主体、政策客体、政策时效、政策领域、政策方式、政策措施,该项政策还需要在面向公众、科技发展、生态与环境保护、强制性法律法规建设、金融与税收方面加大政策支持力度,相关部门应对出现的问题给予更多的关注,做出更加全面的发展规划。

在 9 个一级变量中,得分最高的三个变量依次是 X_5、X_3、X_7,即政策视角(宏观、微观)、政策性质(预测、监管、建议、描述、引导)、政策评价(目标明确、依据充分、规划详实),说明这 8 项康养旅游政策样本在进行康养旅游相关发展规划时,充分考虑到了政策的针对范围,在政策文本中采用多种形式对政策客体进行规划,也制定了相对较为科学的政策实施方案。一级变量中得分较低的三个变量

分别是 X_4、X_9、X_1，即政策时效、政策措施、政策主体，政策时效与政策主体的评分在一定程度上源于省级政策相较于国家级政策的灵活性，而在政策措施方面，在 8 项政策样本中，基本上是因为缺少法律保障、技术支持以及税收优惠相关的政策支持而出现评分较低的情况，这也说明在部分省级政府康养旅游政策制定过程中以上问题是提升政策效果的关键点，应给予更多的关注。

四、结论与建议

本文对 2007—2022 年期间 24 个省份的 86 份康养旅游政策文件进行了政策主题、政策工具、政策效力三个维度的分析，分析结果表明：1）从省域康养旅游政策主题可以看出，地方政府在政策制定过程中较为重视产业发展、产品开发、企业参与，相关体制机制的创新、康养基地建设、乡村建设与发展以及技术提升等成为康养旅游发展的关键性因素，而且康养旅游的发展在很大程度上依托于森林、中医药、温泉等自然资源和专业性的康养人才等人力资源。2）对于政策工具的分析发现，环境型政策工具占比最大，为 68. 93%，供给型政策工具次之，16. 69%，需求型政策工具最少，占比 14. 39%，在比重上环境型政策工具远远多于其他两种政策工具类型，表明地方政府在政策制定过程中出现了政策工具使用失衡的情况；从不同地区使用政策工具的情况来看，沿海地区省份在基础设施建设、科技与信息支持、法规与制度建设、国际交流与合作、市场调动以及政府采购方面发布了相对较多的政策措施，而非沿海地区的康养旅游政策则在人才培养与引进、资金支持以及金融与财税支持方面占据较大比重。3）通过对康养旅游政策效力的分析发现，政策样本整体政策效力表现良好，拉低政策效力评分的因素主要在于缺少法律保障、技术支持以及税收优惠相关的政策支持，以上因素成为提高政策效力的关键点。

根据研究结论以及我国康养旅游发展状况可知，康养旅游政策仍然存在较大的改善空间，政策工具的合理使用以及相关政策措施的制定成为进一步提高康养旅游政策质量的重要方向，据此本文针对康养旅游政策优化提出三点建议：

第一，合理运用政策工具箱，实现政策工具均衡化发展。从政策工具分析结果可知，目前省级政府政策工具使用存在某种程度的失衡，环境型政策工具占比过高，应优化政策工具布局，通过加大政府资金投入以支持科技创新与人才培养，打造信息化、智慧化康养旅游平台，进一步扩大供给型政策工具的使用比例。大力支持“康养论坛”“国际康养旅游峰会”等国际性活动，鼓励各大高校、组织、协会等与国际康养旅游组织学习往来，加强国际交流与合作，扩大需求型政策工具的影响范围。建立健全康养旅游领域法规制度建设，创新管理体制，对金融财税政策进行动态监测，调整环境型政策工具内部协调程度。

第二，积极拓展政策覆盖面，实现政策全方位保障。强化面向公众、技术支持以及税收优惠政策支持成为提高政策效力的关键因素。探索建立面向国家机关、企事业单位干部职工康养制度，拉动康养旅游产业需求；加大康养旅游企业税收优惠以及政府补贴力度，简化企业办事流程，下放康养旅游项目管理权限，拓宽康养旅游项目资金来源，引导康养旅游企业大力开发康养旅游产品，打造国际化康养旅游品牌；建立健全康养旅游保险体系，尝试将部分康复疗养项目纳入医疗保险范畴，减轻群众经济负担，加大节假日公路收费优惠力度，调动游客积极性。

第三,有效整合政策多维度评价方法,实现政策主题、政策工具、政策效力协同发展。在康养旅游多元化、差异化发展的背景下,注重政策主题、政策工具、政策效力的有效结合,发挥政策这只“看得见的手”的调节作用,实现康养旅游的高质量发展。在政策主题维度下,注重康养旅游的全方位建设,在“康养 + 旅游”领域内,实现健康、养生、养老等产业的全要素融合发展,实现法律体系、管理制度、行业标准的全过程监管;在“主题—工具”视角下,确保政策工具的全面性与均衡性,每一政策主题都有一一对应的政策工具;在“主题—工具—效力”三维立体状态下,实现政策主题的全方位覆盖,满足政策工具的合理配置要求,确保每项政策达到效力最大化,最终实现政策主题、政策工具、政策效力的协同发展。

参考文献

[1] 姚力. 新时代十年健康中国战略的部署、推进与成就[J]. 当代中国史研究,2022,29(5):36 - 51 + 157.

[2] 吴文武,张燕婷. 健康中国战略视阈下的康养治理研究[J]. 中国行政管理,2022(2):94 - 99.

[3] 翟燕霞,石培华. 政策工具视角下我国健康旅游产业政策文本量化研究[J]. 生态经济,2021,37(7):124 - 131.

[4] POCOCK N S , KAI H P . Medical tourism and policy implications for health systems: a conceptual framework from a comparative study of Thailand, Singapore and Malaysia[J]. Global Health, 2011, 7(1):12 - 12.

[5] SNYDER J, BYAMBAA T, JOHNSTON R, et al. Outbound medical tourism from Mongolia: a qualitative examination of proposed domestic health system and policy responses to this trend[J]. BMC Health Services Research, 2015, 15(1): 1 - 8.

[6] XU Q , PURUSHOTHAMAN V , CUOMO R E , et al. A bilingual systematic review of South Korean medical tourism: a need to rethink policy and priorities for public health? [J]. BMC Public Health, 2021, 21(1).

[7] 李祇辉. 韩国森林福祉服务体系构建研究——基于韩国林业发展理念、机制与经验的分析[J]. 林业经济,2021,43(4):57 - 69.

[8] 王燕琴,陈洁,顾亚丽. 浅析日本森林康养政策及运行机制[J]. 林业经济,2018,40(4):108 - 112.

[9] 宋瑞,王明康. 欧美主要国家旅游政策内容分析[J]. 杭州师范大学学报(社会科学版),2019,41(1):107 - 117 + 130.

[10] DERCO J. Spa tourism in the Slovak Republic[J]. International Journal of Spa and Wellness, 2020, 3(2 - 3): 187 - 197.

[11] MEDAI N, OKAMOTO N, OGASAWARA Y, et al. Factors contributing to tourism demand at major Japanese hot springs [J]. PloS one, 2022, 17(9): e0274681.

[12] ANAYA - AGUILAR R, GEMAR G, ANAYA - AGUILAR C. Challenges of spa tourism in Andalusia: Experts' proposed solutions[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(4): 1829.

[13] Šenková A, KošíkováM, Matušíková D, et al. Time Series Modeling Analysis of the Development and Impact of the COVID - 19 Pandemic on Spa Tourism in Slovakia[J]. Sustainability, 2021, 13(20): 11476.

[14] 王光明,杨蕊. 基于 NVivo10 质性分析的少数民族数学学习心理因素研究[J]. 民族教育研究,2015,26(1):81 - 84.

[15] ESTRADA M A R. Policy modeling: Definition, classification and evaluation[J]. Journal of Policy Modeling, 2011, 33(4): 523 - 536.

[16] 高昕,孙远太. 基于 PMC 指数模型的乡村振兴政策文本量化评价[J]. 统计与决策,2022,38(19):57 - 60.

[17] 陈子凤,陈媛媛,贾卫峰,等. 我国融合创新政策演进与评价研究[J]. 科技进步与对策,2023,40(18):151 - 160.

[18] ROTHWELL ROY, ZEGVELD W. An assessment of government innovation policies[J]. Review of policy research, 1984, 3: 436 - 444.

[19] 林晓芸,洪燕真,杨小军,等. 森林生态补偿政策量化分析——基于政策建模一致性指数模型[J]. 林业经济,2022,44(8):5 - 23.

[20] 王黎萤,李胜楠,王举铎. 我国工业互联网产业政策量化评价——基于 PMC 指数模型[J]. 工业技术经济,2022,41(11):151 - 160.

[责任编辑:李仲先]

Quantitative Research on Provincial Health and Wellness Tourism Policies Under the Three - Dimensional Analysis Framework

AN Lijuan, XIONG Guobao, YANG Tianyao

(*School of Economics and Management*, *East China University of Technology*, *Nanchang* 330029, *Jiangxi*)

Abstract: The vigorous development of health and wellness tourism has become an important path for the transformation and upgrading of tourism industry. Understanding the current characteristics of health and wellness tourism policies and their prospective development direction will help improve the quality and efficiency of health and wellness tourism. This article first reviews the relevant achievements of foreign health and wellness tourism policies, and then selects 86 health and wellness tourism policies issued by 24 provincial governments from 2007 to 2022 as research objects. Text analysis and PMC index model were employed to construct a three - dimensional analysis framework of "policy themes - policy tools - policy effectiveness" to understand the policy characteristics and existent problems. By means of analyzing word clouds, word frequency tables, and automatic coding results, it was found that the policy themes of health and wellness tourism focused on industrial development, product development, enterprise participation, institutional mechanism innovation, infrastructure construction, and nurturing of health and wellness talents and technology development. Based on the automatic coding, manual coding was conducted to investigate the application of policy tools, and the results revealed that the current use of policy tools is unbalanced, with environmental policy tools accounting for 68.93%, excessively higher than supply - side (16.69%) and demand - side (14.39%) policy tools. Differences were found regarding the application of policy tools between coastal areas and other regions due to the different geographical location and economic development level. Based on the PMC index model, the calculation results show that the overall effectiveness of health and wellness tourism policy samples is above average, but the weaknesses lie in the insufficiency of legal guarantee, technical support and related preferential policy support. Accordingly, the article puts forward relevant suggestions for the formulation of health and wellness tourism policies.

Keywords: health and wellness tourism; PMC index model; text analysis method; three - dimensional analysis framework; health